

Autoclave: control del ciclo, liberación, fallos y retiro

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Asegurar uso del autoclave con carga y parámetros validados, conservando trazabilidad completa de liberación o rechazo.

2. Alcance y condiciones de uso

Módulo condicionado a proceso de esterilización real y competencia técnica. No sustituye manual del autoclave, calificación ni mantenimiento. No fija temperatura, presión o tiempo universales.

MÓDULO CONDICIONAL: documentar oferta, modalidad, competencia y recursos antes de activar. Si no se oferta, justificar no aplicabilidad sin eliminar los controles generales.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Antes del ciclo verificar equipo, instalación, agua requerida, mantenimiento, cámara, empa

Antes del ciclo verificar equipo, instalación, agua requerida, mantenimiento, cámara, empaques y carga. Seleccionar el programa autorizado para el dispositivo, empaque y carga real; registrar versión del manual y validación.

2. Cargar sin obstruir circulación del agente y respetar distribución, peso y compatibilidad

Cargar sin obstruir circulación del agente y respetar distribución, peso y compatibilidad. No mezclar materiales incompatibles ni ejecutar ciclos rápidos para compensar falta de inventario.

3. Registrar identificación del equipo, ciclo, contenido, fecha, operador y controles físicos

Registrar identificación del equipo, ciclo, contenido, fecha, operador y controles físicos: tiempo, temperatura, presión y alarmas que el proceso mide. Mantener impresión o salida electrónica original.

4. Revisar indicadores químicos externos e internos según empaque y método

Revisar indicadores químicos externos e internos según empaque y método. Ubicar BI y control no procesado del mismo lote cuando se realiza monitoreo biológico; registrar incubador, tiempos y lectura conforme a sus instrucciones.

5. Evaluar todos los criterios de liberación: ciclo conforme, indicadores adecuados, empaque

Evaluar todos los criterios de liberación: ciclo conforme, indicadores adecuados, empaque íntegro y seco, resultados requeridos y trazabilidad. No entregar paquete húmedo o sin identificación ni liberar por apariencia del material.

6. Ante fallo o BI positivo detener liberación y retirar equipo conforme al procedimiento, pr

Ante fallo o BI positivo detener liberación y retirar equipo conforme al procedimiento, preservar cargas y registros y gestionar evaluación técnica y repetición validada. Documentar alcance, material distribuido, recuperación y comunicación al responsable clínico.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Parámetros y criterios provienen de manual y proceso calificado.

BI con control y lectura documentados.

Bowie-Dick o prueba de extracción de aire solo cuando tecnología y método lo requieren, no para cualquier autoclave.

Retorno al servicio respaldado por evaluación y evidencia, no solo reinicio.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Decisiones de liberación y trazabilidad

Condición	Decisión segura	Evidencia necesaria
Uso único	No reprocesar para reuso. Retirar y disponer por clasificación.	Etiqueta e identificación.
Manual o compatibilidad ausentes	No iniciar procesamiento ni liberar por apariencia.	Instrucción válida y proceso autorizado.
Fallo físico, químico o empaque húmedo	Cuarentena; investigar y reprocesar solo con procedimiento válido.	Registro de ciclo, paquete, fallo y acción.
BI positivo o control no interpretable	No usar el resultado como negativo. Detener liberación, evaluar alcance y equipo y gestionar controles y retiro.	Lote, control, incubación, lecturas y evaluación competente.
Controles conformes	Liberar solo si se cumplen todos los criterios del proceso validado.	Equipo, carga, lote, paquete, operador y resultado.
Material ya distribuido	Identificar destinatario, recuperar cuando procede y evaluar riesgo clínico.	Trazabilidad hasta paciente o destino, comunicación y acción.

Diferencias de tecnología

La prueba de extracción de aire no corresponde a todos los equipos; el método y frecuencia dependen de autoclave y proceso. Los controles físicos, químicos y biológicos se definen según método y requisitos aplicables. No copiar el ciclo de odontología ni aumentar temperatura para compensar falta de validación.

Proceso contratado

Evaluar el proveedor, acuerdos de calidad, circuito de transporte, contenido y controles de cada entrega. Al recibir comprobar empaque y trazabilidad; conservar rechazo y devolución. Tercerizar no elimina la responsabilidad del prestador sobre desempeño y esterilidad del producto final.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Equipo marca modelo serial	
Ciclo y lote	
Programa y validación	
Carga y empaques	
Controles físicos	
Indicadores químicos	
BI lote control incubación	
Resultado y decisión	
Liberación o cuarentena	
Falla retiro y retorno	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Régimen temporal de reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 como marco previo y Resolución 914 de 2025, artículos 13-15 y manual DMER. El artículo 15 difiere la vigencia general 18 meses desde publicación (03/07/2025): 03/01/2027; revisar reglas particulares de formación y cambios antes de adoptar.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20914%20de%202025.pdf

Referencia técnica de esterilización

CDC, Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities: Sterilizing Practices. Apoyo técnico para monitoreo y respuesta; respetar regulación colombiana, proceso validado y fabricante. No establece por sí sola obligación de autoclave en todo consultorio.

<https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/disinfection-sterilization/sterilizing-practices.html>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576